PROTOCOLLO 6

Valutazione dei rumori articolari

Classificare click e crepitii e collegarli allo stato del disco

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Spostamento discale, artrosi	5 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Click riferiti dal paziente
- ✓ Episodi di blocco in chiusura o apertura
- ✓ Crepitio durante la masticazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, capo neutro.

Fisioterapista: di fronte al paziente, polpastrelli sui poli laterali.

Esecuzione passo dopo passo



Anamnesi del rumore

Chiedi se il paziente sente rumori negli ultimi 30 giorni.



Apertura e chiusura

Ripeti 3 cicli palpando e ascoltando.



Lateralità e protrusione

Ripeti durante i movimenti eccentrici.



Classificazione

Click reciproco, crepitio fine o grossolano, blocchi.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Cicli	3 aperture e chiusure
Movimenti	apertura, lateralità, protrusione
Registrazione	lato, fase e tipo di rumore

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Un click senza dolore spesso non richiede trattamento
- ✓ Il crepitio grossolano orienta verso l'artrosi
- ✓ Annota se il click scompare in protrusione

Errori da evitare

- ! Allarmare il paziente per un click indolore
- ! Non distinguere click da crepitio
- ! Trascurare la storia di blocchi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Osservazione del rumore	Annotare quando compare il click e se è doloroso	per 7 giorni

! **Nota clinica.** Il click reciproco che scompare in protrusione è tipico dello spostamento discale con riduzione.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.